

Programa de tecnovigilancia y gestión de alertas

Programa | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Detectar, reportar y gestionar incidentes o eventos asociados a dispositivos médicos y prevenir repetición.

2. Alcance y condiciones de uso

Equipos y dispositivos utilizados. El independiente puede ser responsable del programa. La ficha interna no sustituye el reporte por el canal institucional o profesional de INVIMA.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Responsable de tecnologías	Controlar compras, recepción, conservación y alertas.
Fisioterapeuta	Revisar elemento antes de usar y reportar señales de daño.
Apoyo autorizado	Registrar inventario, cuarentena y disposición de su alcance.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Designar responsable real y verificar inscripción y canal vigente

Designar responsable real y verificar inscripción y canal vigente. Mantener inventario y formación en detección, incluyendo usuarios y apoyos sin divulgar datos clínicos.

2. Ante suceso atender al paciente, interrumpir el uso y asegurar el dispositivo

Ante suceso atender al paciente, interrumpir el uso y asegurar el dispositivo. Conservar serial, lote, accesorios, parámetros y evidencia; no reparar antes de preservar la información necesaria.

3. Describir tiempo, uso, daño o potencial daño, intervención y condición previa

Describir tiempo, uso, daño o potencial daño, intervención y condición previa. Diferenciar evento con daño e incidente potencial y valorar seriedad con criterio clínico.

4. Reportar eventos e incidentes serios dentro de 72 horas de su ocurrencia conforme al artículo 15 de la Resolución 4816 de 2008.

Reportar eventos e incidentes serios dentro de 72 horas de su ocurrencia conforme al artículo 15 de la Resolución 4816 de 2008. No esperar al cierre de la investigación; usar el canal correspondiente al prestador.

5. Consolidar reportes no serios trimestralmente conforme al artículo 16 y revisar instrucciones vigentes.

Consolidar reportes no serios trimestralmente conforme al artículo 16 y revisar instrucciones vigentes. Conservar radicado, respuesta y seguimiento; no suponer que una llamada al proveedor cumple el reporte externo.

6. Consultar alertas relacionadas con inventario, retirar referencias afectadas y comprobar destino.

Consultar alertas relacionadas con inventario, retirar referencias afectadas y comprobar destino. Analizar causas técnicas y de uso, formar al personal y liberar solo después de evaluación competente.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Gestión inmediata de peligro.

Revisión local de alertas mensual y ante comunicación.

Trazabilidad de radicado y medidas.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.4 y 11.3.1.20-21: medicamentos, dispositivos e insumos. No declarar excluido todo estándar por no usar medicamentos.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Dispositivo serial lote	
Fecha y hora del evento	
Descripción y uso	
Consecuencia o riesgo	
Clasificación de seriedad	
Acción inmediata	
Canal y radicado	
Proveedor informado	
Análisis y medida	
Cierre y eficacia	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Tecnovigilancia

Resolución 4816 de 2008, artículos 12 y 14-16: responsable, información mínima y reporte; serios en 72 horas desde ocurrencia, no serios por consolidado trimestral, por canal aplicable al prestador.

https://normograma.invima.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minproteccion_4816_2008.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576